

Il Corpo Deformato — Disturbi del Comportamento Alimentare

Salute Mentale · Sessione 11

Questa lezione entra in uno dei temi più delicati e culturalmente rilevanti della psicopatologia contemporanea: i disturbi del comportamento alimentare. Non sono solo "problemi di dieta" — sono la storia di come il corpo diventa campo di battaglia dell'identità, della separazione, del controllo. Vale la pena capirli davvero.

Il Cibo Non È Solo Cibo — Valore Simbolico e Relazionale

Partiamo da un dato che sembra ovvio ma non lo è: mangiare non è solo un atto biologico. Il cibo è uno dei primi mediatori della relazione umana. Il neonato incontra il mondo attraverso l'alimentazione — è lì che si costruisce il legame con chi lo nutre, che nascono le prime esperienze di piacere, fiducia, dipendenza.

Come scrive [C. Fischer \(1979\)](#):

"L'uomo è un onnivoro che si nutre di carne, di vegetali e d'immaginario. Il simbolico, l'onirico, i miti e i fantasmi nutrono anch'essi e concorrono a regolamentare il nostro nutrimento."

Questo vuol dire che "diventiamo quello che mangiamo" non solo fisicamente — il cibo definisce la nostra identità, i confini tra sé e l'altro, il rapporto col mondo. Le prime forme di relazione madre-bambino sono regolate sull'attività alimentare e prefigurano le relazioni future.

Il cibo è anche marcatore culturale: ogni etnia lo mette al centro della propria identità, i migranti conservano i pasti tradizionali come legame con le origini, le grandi occasioni sociali ruotano quasi sempre attorno a un tavolo. Anche il gusto

non è neutro: è elaborato dal cervello in base alla cultura, alla memoria (ippocampo) e alle emozioni (amigdala, sistema limbico).

Il professore sottolinea però un cambiamento: nella modernità il pasto da momento di unione sta diventando momento di divisione. L'antropologo Marino Niola parla di "tribù alimentari" — vegani, crudisti, ortoressici, fitness-isti — ognuna con i propri tabù e le proprie ossessioni. Siamo, dice Niola, quello che **non** mangiamo, piuttosto che il contrario.

Classificazione Attuale dei Disturbi (DNA — DSM-5-TR)

I **Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA)** sono definiti come "un persistente disturbo dell'alimentazione o di comportamenti collegati con l'alimentazione che determinano un alterato consumo o assorbimento di cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale" (APA, 2023).

Il DSM-5 distingue **sei categorie principali**, più una residuale:

Disturbo	Caratteristica principale	Età tipica
Pica	Ingestione di sostanze non commestibili (sassi, plastica)	Infanzia, disabilità intellettive
Disturbo da ruminazione	Rigurgito ripetuto del cibo appena mangiato	Infanzia, ma non solo
Disturbo evitante/restrittivo	Alimentazione molto selettiva, fobia di cibi nuovi	Infanzia
Anoressia nervosa	Restrizione calorica, paura del peso, alterazione immagine corporea	Adolescenza/adulti
Bulimia nervosa	Abbuffate + comportamenti compensatori	Adolescenza/adulti

Disturbo	Caratteristica principale	Età tipica
Disturbo da binge-eating (BED)	Abbuffate senza compensazione sistematica	Adulti

Il BED è stato riconosciuto come entità autonoma solo nel 2013 con il DSM-5. Negli ultimi anni i quadri "puri" (anoressia o bulimia classica) sono diventati meno frequenti rispetto a forme miste, transizioni tra un disturbo e l'altro, e **sindromi sottosoglia**.

Anoressia Nervosa

Criteri principali (DSM-5-TR): - **Restrizione calorica** che porta a un peso significativamente inferiore al minimo normale - **Paura intensa** di aumentare di peso (o comportamenti persistenti che interferiscono con l'aumento) - **Alterazione dell'immagine corporea**: il peso/forma corporea influenzano in modo eccessivo l'autostima, oppure c'è mancato riconoscimento della gravità del sottopeso

Due sottotipi: **AN con restrizioni** (solo dieta/digiuno/esercizio) e **AN con abbuffate/condotte di eliminazione**.

Il termine "anoressia" (mancanza di appetito) è parzialmente fuorviante: nelle prime fasi la fame c'è eccome, ed è necessario uno sforzo enorme per resistere. Solo più tardi il corpo si adatta e la fame diminuisce. Pensala come una pianta che resiste alla siccità: nei primi giorni il bisogno d'acqua è acuto, ma poi i meccanismi di adattamento entrano in gioco e la pianta sembra quasi non aver più bisogno di nulla — ma in realtà sta esaurendo le riserve.

Bulimia Nervosa

Caratterizzata da: - **Episodi ricorrenti di abbuffata** (quantità eccessiva + sensazione di perdita di controllo) - **Comportamenti compensatori inappropriati** (vomito autoindotto nell'80% dei casi, lassativi, diuretici, digiuno, esercizio eccessivo) - Frequenza: almeno una volta a settimana per tre mesi - **Autovalutazione indebitamente influenzata** dalla forma e dal peso corporeo

Nota importante: anoressia e bulimia sono spesso due facce della stessa medaglia. L'anoressia è il polo del **controllo rigido**, la bulimia è il polo della **perdita di controllo** — e spesso c'è oscillazione tra i due nel corso del tempo. Dal punto di vista psicodinamico le problematiche alla base possono essere le stesse.

Disturbo da Binge-Eating (BED)

Come la bulimia per le abbuffate (perdita di controllo, almeno 1 volta/settimana per 3 mesi), ma **senza comportamenti compensatori sistematici**. Le abbuffate avvengono spesso in solitudine, con vergogna, disgusto verso sé stessi e senso di colpa che perpetua il ciclo. Correlato all'obesità in una certa percentuale di casi.

Il Sintomo Anoressico nella Storia — Quattro Epoche

L'anoressia non è un'invenzione dei social media. Possiamo distinguere quattro fasi storiche (Cosenza, 2008):

- 1. L'epoca delle "mosche bianche" (anni '60)** Appaiono le prime pazienti anoressiche negli ospedali, durante il boom economico. Prevalentemente donne e adolescenti, con sintomo esclusivamente restrittivo (nessuna pratica evacuativa).
- 2. La "malattia d'elezione delle ragazze di buona famiglia" (anni '70)** Bruch (1978) descrive l'anoressia come disturbo della classe borghese, diffuso a partire dagli USA verso Europa e Giappone. Ruolo emergente di moda e televisione nella diffusione degli ideali di magrezza femminile.
- 3. La svolta degli anni '80-'90** Compaiono le forme bulimica (abbuffate + evacuazione). Il corpo viene "riempito e svuotato". Si diffonde anche l'obesità, e i disturbi raggiungono anche le classi popolari.
- 4. L'epoca attuale (dal 2000)** Tre fenomeni caratteristici (Cosenza, 2008): - **Poliabuso e comorbidità**: una persona bulimica abusa anche di alcol o cocaina — la monosintomaticità si indebolisce - **Globalizzazione del sintomo**: anoressiche appaiono ora anche in Africa del Nord e Medio Oriente, dove la cultura si

occidentalizza - **Internet e siti pro-ana**: l'anoressia diventa identità collettiva — "io sono ana" — con legami comunitari fondati sul sintomo e non sullo scambio autentico

Il prof sottolinea: in questo millennio dove le questioni identitarie sono centrali, il web ha fornito (spesso in modo disfunzionale) una soluzione: un'identità pronta, cristallizzata sul sintomo. Come un'armatura che protegge ma imprigiona.

La Scissione Mente-Corpo nell'Anoressia

Un nodo concettuale centrale. Fin dall'Antichità (dualismo cartesiano) e ancor più nella tradizione cristiana medievale, corpo e anima erano visti come separati e spesso antagonisti — il corpo come "sede dei peccati" da mortificare.

Pensa a **Santa Caterina da Siena**: viveva in un contesto dove il suo destino era già segnato (matrimonio, figli). Attraverso il quasi-digiuno (sopravviveva con l'ostia al giorno) acquisì un prestigio enorme nel clero. Il controllo del corpo come unico strumento disponibile per costruire un'identità autonoma e ottenere riconoscimento — esattamente il meccanismo che troviamo ancora oggi.

Mara Selvini-Palazzoli (1963) fu la prima ad avanzare l'ipotesi fondamentale: **nell'anoressia la ragazza non ha paura del cibo, ma del suo corpo**. Il cibo ingerito viene vissuto come un'espansione del corpo a detrimento del sé. Il corpo adolescente — specialmente per le ragazze, il cui corpo in pubertà si avvicina a quello della madre — può diventare persecutorio, estraneo, "il nemico".

Il disturbo alimentare servirebbe quindi a funzioni **autarchiche**: illudere che il corpo possa vivere senza apporti esterni, trionfo dello spirito sul corpo. **I DCA rientrano tra le patologie narcisistiche.**

Il mito di **Eco e Narciso** (Ovidio) illustra bene la dinamica: Eco, privata della parola da Era, non può comunicare il suo amore. Narciso, innamorato della propria immagine, smette di mangiare e annega nello specchio. Il sintomo anoressico come manifestazione dell'impossibilità di comunicare, della difficoltà a stabilire relazioni, dell'investimento narcisistico sul corpo.

I DCA Come Disturbi Etnici — La Cultura Plasma la Malattia

Qui c'è un concetto fondamentale che il prof sottolinea con forza.

Georges Devereux (1978), psicoanalista e antropologo, ha sviluppato il concetto di **disturbo etnico** (oggi: *Culture-Bound Syndrome* — Sindrome Culturalmente Caratterizzata). Ogni cultura possiede uno o più disturbi "strutturati culturalmente" — manifestazioni psicopatologiche specifiche di un contesto storico.

Esempi: l'Amok dei Malesi, il Windigo degli Algonchini, il **Cane Pazzo** dei Crow (un guerriero nativo che, di fronte a una "delusione insopportabile", impazzisce in modo socialmente codificato — e la cultura ne fa uso strategico in battaglia).

I criteri di un disturbo etnico includono: - È frequente in quella cultura rispetto ad altre forme di disagio - C'è continuità formale tra elementi normali della cultura e i sintomi (esagerazione di comportamenti considerati normali o positivi) - Esprime i conflitti fondamentali della società - Offre un "modello di cattiva condotta" socialmente strutturato

L'anoressia risponde a tutti questi criteri: il "tenere duro", l'esercizio fisico costante, il rispettare un canone di bellezza — sono comportamenti che inizialmente vengono **ammirati**. Quando diventano patologici, possono ancora suscitare un'ammirazione segreta, perché esprimono contraddizioni che tutti percepiscono.

Distinzione cruciale (che il prof sottolinea esplicitamente): la cultura non è la **causa** dei DCA — è un **fattore patoplastico** (il "Zeitstil" di Jaspers). Non determina la malattia, ma ne plasma la **forma** in cui una sofferenza individuale si esprime. Chi ha una vulnerabilità psichica si ammala; la cultura indica il modo in cui quella sofferenza si manifesta.

Come dice il prof: "La ragazza che oggi sviluppa l'anoressia, a inizio Novecento avrebbe sviluppato l'isteria."

I Nuovi Fenomeni: Ortoressia e Vigoressia

I disturbi alimentari si sono modificati — **accelerazione evidente con il COVID-19** (Riva, 2022).

Ortoressia

Dal greco *orthos* (corretto) + *orexis* (appetito). **Ossessione per il "mangiare sano"**: non è più la quantità a essere controllata, ma la qualità. Il cibo "contaminato", "non biologico", "non puro" diventa un nemico. La preoccupazione può estendersi all'intera biosfera (animalismo, ambientalismo).

Caratteristiche: - Non riesce a uscire a cena con gli amici (il ristorante non garantisce i "suoi" cibi) - Gira con la propria "cassetta degli attrezzi" alimentare - Guarda con disprezzo chi non mangia come lei/lui - Aspetto del controllo elevato all'ennesima potenza

Non è ancora nel DSM, ma è in forte aumento. **Il prof cita lo studio di Laura Dalla Ragione: una diagnosi di allergia o intolleranza alimentare — spesso fatta da professionisti non medici o test non attendibili — può colludere con una visione ipocondriaca del mondo e favorire comportamenti fortemente restrittivi.**

Vigoressia

Conosciuta anche come **Muscle Dysmorphia** o "complesso di Adone". Descritta inizialmente come "anoressia inversa" (Pope, 1993): **il soggetto — prevalentemente giovane maschio — si vede sempre troppo esile, mai abbastanza muscoloso, nonostante la corporatura atletica oggettiva.**

Caratteristiche: - Dismorfismo corporeo (come l'anoressia, ma speculare) - Vita centrata su training, proteine, supplementi - Dimagrimento spesso come effetto secondario (non è l'obiettivo principale) - Ora si diffonde anche tra le adolescenti

La differenza con il sano interesse per la palestra? Quando diventa ossessivo, quando nessun livello è mai abbastanza, quando la vita ruota tutta attorno a quella forma fisica irraggiungibile.

Confronto: Anoressia vs Ortoressia/Vigoressia

Dimensione	Anoressia nervosa	Ortoressia e vigoressia
Identità	Trionfo della mente: corpo ridotto a scheletro	Corpo forte, sano, vincente
Rifiuto	Del corpo pubere e del destino femminile	Marcatura narcisistica, diffidenza verso la dipendenza
Tema del controllo	Obiettivo: dimagrimento	Autorassicurazione fine a sé stessa
Immagine corporea	Dispercezione della propria magrezza	Bisogno di controllo; dispercezione non sempre presente
Cibo	Repulsione, negazione del desiderio	Controllo rigido della qualità; non necessariamente repulsione
Peso	Sottopeso fino a grave magrezza	Variabile (sottopeso possibile, raramente)

Eziologia Multifattoriale — Perché Nasce un DCA

Non esiste una causa unica. Il modello è **multifattoriale** su tre livelli:

Fattori Predisponenti

Aumentano la vulnerabilità, sono presenti prima del disturbo: - **Genetici**: personalità con tratti ossessivi e perfezionistici; predisposizione all'obesità infantile (correlata alla bulimia) - **Psicologici**: personalità premorbosa con alta instabilità dell'umore, bassa autostima, perfezionismo ossessivo - **Familiari**: comportamento alimentare della madre come modello; commenti critici sul peso da parte dei genitori; abuso di alcol/sostanze in famiglia - **Socioculturali**: ideale di magrezza nei paesi occidentali come pressione normativa sulle donne

Fattori Precipitanti

Scatenano l'esordio in una persona già vulnerabile: - Lutti, separazioni, aggressioni - Fallimenti scolastici, cambi di scuola, prese in giro per l'aspetto - **Traumi sessuali (fattore di rischio non specifico)** - Problemi interpersonali: bassa autostima + deficit di competenze sociali

Fattori Cronicizzanti

Impediscono il ritorno alla normalità: - **Effetti del digiuno prolungato:** aumento biologico degli stimoli di sopravvivenza (fame, ossessione per il cibo) → spinta compulsiva verso il cibo - **Fattori cognitivi:** difficoltà di concentrazione, ridotta capacità di cogliere la realtà, che rendono difficile la presa di coscienza - **Alterazioni gastrointestinali:** vomito autoindotto provoca infiammazioni dell'esofago, stipsi, compromissione circolatoria - **Distorsione dell'immagine corporea:** il soggetto continua a vedersi grasso anche gravemente dimagrito → **persiste la necessità di dimagrire** - **Ruolo della famiglia:** trasversale a tutti i livelli di rischio

Il prof è chiaro: la presa in carico deve essere **multidisciplinare** (psicologo, nutrizionista, medico internista) e coinvolgere la famiglia. Lavorare solo sull'alimentazione è controproducente.

Aspetti Psicodinamici — Cosa Sta Davvero Dietro il Sintomo

Fin qui la parte più descrittiva. Ora viene quella interpretativa — fondamentale per capire il lavoro terapeutico.

Il Controllo Come Unica Libertà

Il prof lo dice chiaramente: il controllo sull'alimentazione in contesti dove non si ha controllo sulla propria vita è un meccanismo comprensibile. Pensiamo a Caterina da Siena — o a qualsiasi adolescente che sente che la propria vita è decisa dagli altri. Il digiuno come unica zona franca.

Il Processo di Separazione-Individuazione

Molti autori psicomodinamici concordano: alla base dei DCA ci sono spesso difficoltà nel **processo di separazione e individuazione** (Mahler) — quel percorso che avviene nei primi 2-3 anni di vita in cui il bambino comincia a costruire un sé distinto dalla madre.

Hilde Bruch osservò nelle ragazze anoressiche un sentimento di mancanza di valore e di efficacia, derivante dal **disconoscimento dei bisogni autentici** nell'infanzia. Erano "bambine perfette" — non davano problemi — ma i loro bisogni reali non erano stati visti. Per avere l'amore del genitore avevano costruito un **falso sé compiacente**.

Il sintomo anoressico, simbolicamente, dice: "Sono io che decido cosa entra nel mio corpo." Ma contemporaneamente c'è un desiderio di dipendenza irrisolto. Questa dialettica oscillante tra dipendenza e autonomia è il cuore psicomodinamico del disturbo.

A livello simbolico: - **Abbuffata** (nella bulimia) = riempire il vuoto, ritrovare la dipendenza - **Vomito** = spingere via, cercare autonomia - **Restrizione anoressica** = illusione di bastare a sé stessi, non aver bisogno di nessuno

L'Identità Come Funzione del Sintomo

In un'epoca di "identità liquida" dove costruire chi si è è sempre più complesso, i disturbi alimentari possono offrire una soluzione — disfunzionale, ma efficace nell'immediato: "Io sono anoressica" è un'identità chiara, riconoscibile. Il sintomo diventa qualcosa di prezioso da proteggere, che regge un narcisismo fragile.

L'Immagine Corporea Distorta

Un aspetto clinico centrale: la **dispercezione corporea**. Chi soffre di anoressia non si vede come è realmente — si vede grassa anche pesando 35 kg. Questo avviene su due livelli: - **Percettivo**: errore nella stima delle proprie dimensioni corporee - **Affettivo**: insoddisfazione profonda verso il proprio corpo

Una tecnica terapeutica descritta: far disegnare alla ragazza la propria immagine corporea come la percepisce, poi sovrapporre il contorno reale. La differenza tra i due contorni può aprire una riflessione — non è la cura, ma è un primo punto di contatto, un modo per tematizzare e avviare la presa in carico.

In casi estremi si può arrivare a una **scissione mente-corpo**: il corpo viene vissuto come persecutorio, estraneo. Questo è clinicamente pericoloso perché può portare a ideazione suicidaria — non come desiderio di morte, ma come tentativo di liberarsi del corpo.

Implicazioni per il Lavoro Sociale

Il prof è esplicito: **come educatore, non è compito tuo gestire l'aspetto alimentare**. Quello lo fa il medico, il nutrizionista, lo psicologo.

Cosa può fare l'educatore/operatore sociale: - Costruire una relazione di fiducia (il "muro dell'anoressia" è reale — ci vuole tempo) - **Non** focalizzarsi su "cosa hai mangiato" — i temi sono alti, relazionali, affettivi - Capire che una ricaduta non è una sconfitta — fa parte del processo di guarigione - Lavorare in rete con tutti i professionisti coinvolti - **Tenere presente che il sintomo è una comunicazione — c'è qualcosa che la persona non riesce a dire altrimenti**

Un caso illustrativo (dalla trascrizione): una ragazza in un istituto che aveva lavorato bene durante la settimana ma al rientro nel weekend a casa ritornava agli schemi patologici. Il lavoro deve includere la famiglia — o almeno non ignorarne il ruolo. E bisogna non abbattersi di fronte alle ricadute.

Concetti Chiave

Termine	Significato
DNA	Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione — categoria diagnostica del DSM-5
Anoressia nervosa	

Termine	Significato
	Restrizione calorica + paura del peso + distorsione dell'immagine corporea
Bulimia nervosa	Abbuffate + comportamenti compensatori (vomito nell'80% dei casi)
BED	Binge-Eating Disorder — abbuffate senza compensazione, riconosciuto nel DSM-5 nel 2013
Ortoressia	Ossessione per il "mangiare sano" (qualità, non quantità)
Vigoressia / Muscle Dysmorphia	Dismorfismo corporeo "inverso" — mai abbastanza muscolosi
Disturbo etnico / Culture-Bound Syndrome	Manifestazione psicopatologica specifica di una cultura (Devereux)
Fattore patoplastico	La cultura non causa la malattia, ma ne plasma la forma espressiva
Separazione-individuazione	Processo evolutivo dei primi anni di vita — difficoltà in questo processo come fattore predisponente
Falso sé	Maschera compiacente costruita per ottenere l'amore del genitore, disconnessa dai bisogni autentici (Bruch)
Dispercezione corporea	Errore nella percezione delle proprie dimensioni corporee (percettivo + affettivo)
Siti pro-ana	Comunità online che rinforzano l'identità anoressica/bulimica
Fattori predisponenti	Aumentano la vulnerabilità (genetici, psicologici, familiari, socioculturali)

Termine	Significato
Fattori precipitanti	Scatenano l'esordio (eventi stressanti, traumi, problemi interpersonali)
Fattori cronicizzanti	Perpetuano il disturbo nel tempo

Domande di Orientamento allo Studio

Cosa si intende per "fattore patoplastico" e perché è importante per comprendere i DCA? Il **fattore patoplastico** (concetto di **Jaspers**, ripreso da Devereux) è ciò che plasma la forma in cui una sofferenza individuale si esprime, senza causarla direttamente. Nel caso dei DCA, la cultura — con il suo culto della magrezza, dell'immagine corporea, della performance — non causa il disturbo, ma ne modella l'espressione. Una persona con una vulnerabilità psichica preesistente si ammala; la cultura indica il modo in cui quella sofferenza si manifesta. **Come dice il prof: la stessa ragazza vissuta nell'800 avrebbe sviluppato l'isteria, non l'anoressia. È importante perché significa che demonizzare la cultura (i social, la moda) come causa diretta è un errore: bisogna agire sulla sofferenza profonda, non solo sull'influenza culturale superficiale.**

Quali sono i tre livelli di fattori eziologici nei DCA e cosa li distingue? I fattori si distinguono per il loro ruolo nel processo morboso. I **predisponenti** (genetici, psicologici, familiari, socioculturali) aumentano la vulnerabilità e sono presenti prima del disturbo. I **precipitanti** sono eventi o situazioni che scatenano l'esordio in una persona già fragile (lutti, traumi, fallimenti, prese in giro per l'aspetto). I **cronicizzanti** sono i meccanismi che impediscono il ritorno alla normalità, come gli effetti biologici del digiuno che aumentano la spinta al cibo, la distorsione dell'immagine corporea che perpetua il bisogno di dimagrire, o le dinamiche familiari che rinforzano il disturbo.

In cosa differisce l'anoressia nervosa dalla bulimia nervosa dal punto di vista clinico? Entrambe condividono un'autovalutazione indebitamente influenzata dalla forma e dal peso corporeo, e spesso c'è oscillazione tra le due sindromi nel corso della vita. La differenza principale è che nell'anoressia c'è

restrizione calorica con sottopeso significativo e paura intensa di ingrassare, mentre nella bulimia ci sono abbuffate seguite da comportamenti compensatori sistematici (vomito nell'80% dei casi), ma non necessariamente sottopeso. Dal punto di vista psicodinamico, l'anoressia è il polo del controllo rigido, la bulimia è il polo della perdita di controllo con impulsività.

Cosa sono i "disturbi etnici" secondo Devereux e in che senso i DCA rientrano in questa categoria? I disturbi etnici (Culture-Bound Syndromes) sono manifestazioni psicopatologiche specifiche di una cultura: esprimono i conflitti fondamentali di una società attraverso "modelli di cattiva condotta" socialmente strutturati. I DCA rientrano in questa categoria perché: portano all'eccesso comportamenti che la cultura considera normali o positivi (controllare l'alimentazione, fare sport); sono tipici del mondo occidentalizzato e si diffondono dove la cultura occidentale si espande; esprimono una crisi dell'identità femminile specifica della nostra epoca. Come il "Cane Pazzo" dei Crow era una forma di follia culturalmente prevista e codificata, l'anoressia è la nostra forma socialmente strutturata di esprimere il disagio.

Qual è il ruolo della scissione mente-corpo nell'anoressia, secondo Selvini-Palazzoli? Selvini-Palazzoli (1963) fu la prima a sostenere che nell'anoressia la ragazza non abbia paura del cibo ma del suo stesso corpo. Il corpo viene vissuto come estraneo, persecutorio, non appartenente al sé — specialmente in pubertà, quando il corpo femminile si avvicina a quello della madre, rendendo più difficile la separazione psicologica da essa. Il disturbo alimentare ha quindi una funzione autarchica: l'illusione di poter vivere senza apporti esterni, un trionfo dello spirito sul corpo. Il cibo ingerito è vissuto come un'espansione del corpo a detrimento del sé.

Cosa differenzia ortoressia e vigoressia dall'anoressia restrittiva classica? Condividono la difficoltà a trovare un'identità e il tema del controllo, ma con declinazioni diverse. Nell'anoressia classica il controllo mira al dimagrimento e c'è spesso dispercezione della propria magrezza; c'è repulsione verso il cibo e rifiuto del corpo pubere. Nell'ortoressia il controllo riguarda la qualità del cibo, il corpo ideale è forte e sano, e la preoccupazione può estendersi agli altri esseri viventi; la dispercezione non è sempre presente. Nella vigoressia c'è un dismorfismo corporeo inverso (mai abbastanza muscolosi), il dimagrimento è un effetto secondario non

cercato, e predomina nei maschi. In entrambi i nuovi quadri l'autocontrollo è un fine in sé, non un mezzo per dimagrire.

Collegamenti

Lezioni precedenti - Il modulo sulle fiabe (citato nella trascrizione): il cibo nelle fiabe come simbolo di vita/morte, amore/odio, pieno/vuoto — Hansel e Gretel è l'esempio diretto citato dal prof - Il processo di **separazione-individuazione** (Mahler) già trattato nelle lezioni sullo sviluppo - Il **narcisismo** e le patologie narcisistiche come framework

Temi aperti / da approfondire - Lettura consigliata: *Petite* di Geneviève Brisac — romanzo autobiografico su un'anoressia adolescenziale - Aspetti neurobiologici: sistema di ricompensa (reward system), ruolo degli oppioidi endogeni e della dopamina nel comportamento alimentare compulsivo - La questione delle **intolleranze alimentari auto-diagnosticate** come potenziale fattore di rischio - Il ruolo di **internet e social media** — siti pro-ana, nutrizionisti influencer — e i meccanismi di amplificazione degli ideali corporei